

TRASTORNO DE LA ALIMENTACION Y LA ALIMENTACION

REFLEXION

“ El síntoma alimentario es el grito desesperado de un alma que no encuentra palabras para su dolor. Sanar la relación con la comida exige primero sanar la relación con el propio ser.”



Introducción



Los trastornos alimentarios representan desafíos críticos en la psicología clínica moderna debido a su multicausalidad biopsicosocial. Comprender sus mecanismos es vital para implementar intervenciones afectivas y éticas.

PRINCIPALES TRASTORNOS

ANOREXIA NERVIOSA (AN)



- Restricción de la ingesta energética conlleva un peso corporal significativamente bajo.
- Miedo intenso a ganar peso.
- Alteración de la percepción propia
- Este trastorno se puede dividir en 2 tipos: restrictivo y atracones/purgas



PRINCIPALES TRASTORNOS

BULLIMIA NERVIOSA (BN)

Episodios recurrentes de atracones (comer cantidades excesivas) seguido de comportamientos compensatorios inapropiadas como el vomito inducido, para evitar el aumento de peso.

PRINCIPALES TRASTORNOS

TRASTORNO POR ATRACON (TA)

- Episodios recurrentes de atracones sin conductas compensatorias regulares, lo que a menudo provoca sobrepeso.



PRINCIPALES TRASTORNOS



TRASTORNO DE EVITACION/RESTRICCION DE LA INGESTA DE ALIMENTOS (TERIA/ARFID)

- Falta de interés en comer o evitación sensorial de alimento que resulta pérdida de peso significativa o deficiencias nutricionales, sin distorsión de la imagen corporal.

PRINCIPALES TRASTORNOS

OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS (OSFED)

Presentaciones de TCA que causan malestar clínicamente significativo pero no cumplen todos los criterios de los anteriores, como la anorexia nerviosa atípica ya que pierden peso, pero su peso está dentro o por encima de su rango normal.



PRINCIPALES TRASTORNOS

TRASTORNO DE PICA

- ➡ Es la ingesta persistente de sustancias no nutritivas y no alimentarias como tierra, papel, jabón, pelo durante al menos un mes. La conducta debe ser inapropiada para el nivel de desarrollo.



PRINCIPALES TRASTORNOS

TRASTORNO DE RUMIACION

- ➡ Se caracteriza por la regurgitación repetida y sin esfuerzo de alimentos durante al menos un mes, los cuales pueden ser Re - masticados, tragados o escupidos.
- ➡ Puede provocar pérdida de peso, desnutrición, mal aliento y problemas dentales.



ESTADISTICAS

En Panamá no existen estadísticas poblacionales centralizadas y exhaustivas sobre la prevalencia de los **trastornos de la conducta alimentaria (TCA)**.

Comparativo de prevalencia por diagnostico (datos 2024 – 2025) Según la OMS

TIPO DE TRATORNO	PREVALENCIA ESTIMADA
TRASTORNO POR ATRACON	1.2% - 1.6%
BULLIMIA NERVIOSA	0.3 – 0.5
ANOREXIA NERVIOSA	0.16% – 0.5%
OTROS NO ESPECIFICADOS	1.1% - 1.3%

En estos trastornos existe una brecha de genero, siendo mas frecuentes las mujeres a pesar de que en los últimos años se ha dado un incremento en la población masculina.

La OMS destaca que la anorexia nerviosa tiene una tasa de mortalidad mas altas de las enfermedades psiquiátricas, superando el trastorno por consumo de sustancias.

CUADRO COMPARATIVO DSM 5- TR Y CIE - 11

Criterio	DSM 5- TR	CIE - 11
CATEGORIAS	CRITERIOS MUY ERICTOS	ENFASIS EN LA FUNCIONALIDAD Y LA CRONICIDAD
ANOREXIA	PESO SIGNIFICATIVAMENTE BAJO	PESO CORPORAL INFERIOR A LA NORMA
BULLIMIA	ATACASCONES Y PURGAS 1 VEZ/SEMANA	PATRON REPETIDO DE ATRACONES/PURGAS
ATRACON	EPISODIOS DISCRETOS Y MALESTAR	ENFASIS EN LA PERIDA DE CONTROL
TRASTORNO POR EVITACION	AGRUPA A NIÑOS Y AÑADE ESPECIFICACIONES PARA ADULTOS	CASI SIMILAR, PERO AGRUPA MAS ESTRECHAMENTE EN EL DESARROLLO NORMAL DE LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA

INVESTIGACION: El Impacto de las Redes Sociales y la Imagen Corporal (2021-2023)

- Una de las áreas con mayor volumen de publicaciones analiza cómo plataformas como Instagram y TikTok han exacerbado la insatisfacción corporal. Estudios transversales realizados en jóvenes de entre 18 y 30 años confirman que la exposición continua a ideales de delgadez y la "cultura de la dieta" en redes es un factor de riesgo directo.

ENLACE: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2529-850X2021001001289&hl=es-US

RESUMEN DE LA INVESTIGACION

INTRODUCCION	OBJETIVO	METODO	RESULTADOS	CONCLUSION
Tras el COVID-19 las nuevas tecnologías han tomado aún más relevancia en nuestra sociedad, entre estas, las redes sociales. El uso de estas redes no para de crecer cada año y su uso es cada vez más extendido. Por otro lado, los Trastornos de la Conducta Alimentaria también están a la orden del día, y durante la cuarentena salieron a relucir un considerable número de casos.	La siguiente investigación trata de comprobar si existe relación entre el uso de las redes sociales y el riesgo a desarrollar un Trastorno de la Conducta Alimentaria en jóvenes.	El diseño fue relacional transversal. Se encuestó de forma online y anónima a 108 jóvenes de entre 18 y 30 años. La encuesta se compuso del instrumento Eating Attitudes Test-26 y preguntas elaboradas por los investigadores sobre el uso de redes sociales y salud.	Los resultados mostraron una relación significativa entre la frecuencia de uso de redes sociales y tener una experiencia negativa en el uso de las mismas, con el riesgo de padecer un Trastorno de la Conducta Alimentaria.	Tras esta investigación podemos concluir que el uso de redes sociales puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de un Trastorno de la Conducta Alimentaria, aunque son necesarias más investigaciones.

FAMOSOS CON EL TRASTORNO DE LA ALIMENTACION Y LA ALIMENTACION

Zayn Malik



Durante su etapa en One Direction, el cantante admitió haber sufrido periodos en los que no ingería ningún alimento durante días como una forma de recuperar el control sobre su vida

Lady Gaga



Confesó haber padecido bulimia y anorexia desde los 15 años. Ha utilizado su plataforma para hablar sobre la presión de la industria y promover el amor propio.

Demi Lovato



Ha sido una de las voces más abiertas sobre su lucha contra la bulimia, el trastorno por atracón y los problemas de imagen corporal, buscando siempre ayudar a sus seguidores.



SIGNOS DE UN TRASTORNO ALIMENTARIO



Líneas de Ayuda y Centros Gratuitos

- **Línea 147 (MIDES):** Atención profesional en salud mental, orientación y apoyo emocional 24/7, disponible también por WhatsApp al 6694-2747.
- **Instituto Nacional de Salud Mental (INSAM):** Ofrece atención especializada. Contacto: 523-6813 / 523-6846.
- **Te Escucho Panamá:** Línea de apoyo emocional (lunes a viernes de 5 p.m. a 10 p.m.): 831-7600.
- **Cruz Blanca Panameña:** Teléfono: 6674-9695 / WhatsApp: 6020-9825.
- **Clínica Psicológica de la Universidad de Panamá:** 523-7471.

Recomendaciones Adicionales:

- **Centros de Salud y CSS:** Se puede solicitar referencia para psicología en los centros de salud del MINSA o la Caja de Seguro Social (CSS).
- **Emergencias:** En caso de crisis severa o riesgo de suicidio, llame al 911



*SACRIFICAR SU SALUD MENTAL PARA
CUMPLIR CON LOS ESTANDARES DE
BELLEZA*



NO VALE LA PENA.

A close-up photograph of a person's open palm holding a small, rectangular piece of white paper with deckled, torn edges. The word "Gracias." is written on the paper in a black, elegant cursive script. The background is the skin of the hand, showing natural creases and lines. The entire image is set against a light cream-colored background.

Gracias.